

Réglementations certificats médicaux d'inaptitude

Les mesures réglementaires qui s'appliquent aux certificats médicaux d'aptitude et aux préconisations d'inaptitude sont principalement encadrées par le Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 et l'Arrêté interministériel du 16 octobre 2001.

La Fiche de visite médicale individuelle (Certificat d'aptitude) En médecine du travail, le document statuant sur l'aptitude est officiellement appelé « Fiche de visite médicale individuelle »[1][2]. Les règles suivantes s'y appliquent :

- Délivrance et renouvellement : Le médecin du travail doit établir cette fiche en y précisant la conclusion d'aptitude au moment de l'embauchage[1]. Ce document doit ensuite être obligatoirement renouvelé à chaque visite médicale périodique ainsi qu'à chaque visite de reprise du travail[1].
- Destinaire et obligation de conservation : Contrairement au dossier médical individuel qui est couvert par le secret professionnel et conservé sous clef par le médecin[3], la fiche d'aptitude est destinée à l'employeur[1]. L'employeur a l'obligation légale de la conserver afin de pouvoir la présenter à l'inspecteur du travail lors d'un contrôle[1].
- Contenu formel : La fiche doit impérativement comporter l'identité du travailleur, l'organisme employeur, la profession, le poste de travail exact, la date de la visite, la conclusion médicale, l'identification du service de médecine du travail ainsi que la signature et le cachet du médecin[2].

L'évaluation de l'aptitude et les préconisations d'inaptitude L'objectif de la visite médicale est de s'assurer que le travailleur est apte au poste envisagé, de dépister toute affection constituant une contre-indication à ce poste, et de proposer des adaptations si nécessaire[6].

Le médecin du travail dispose de quatre (04) conclusions médicales réglementaires pour statuer sur l'aptitude[7] :

1. Apte : Le travailleur peut occuper son poste sans restriction[7].
2. Apte avec réserves : Le médecin valide l'aptitude mais émet des préconisations d'aménagement. Dans ce cas, il doit obligatoirement mentionner par écrit les postes conseillés et les postes déconseillés pour adapter le travail à la physiologie du travailleur[6][7].
3. Inapte temporaire : L'état de santé du travailleur justifie une inaptitude momentanée à son poste[7].
4. Inapte définitif : Le travailleur présente une contre-indication absolue et permanente à l'occupation de ce poste[7].

Enfin, lorsque les préconisations du médecin du travail (réserves ou inaptitude) nécessitent de changer l'affectation du salarié, la réglementation exige que toute reconversion de poste fasse l'objet d'une nouvelle visite médicale afin de vérifier formellement l'aptitude du travailleur au nouveau poste de travail envisagé[6].

Sources

[1] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[2] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[3] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[6] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/51_93-120.pdf

[7] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>